



新光醫院急診醫學科

科部再發展計畫

Reinvent the Landscape of Emergency Medicine

新光是現今台灣急診的起點 急診的下一個時代，也將從這裡開始

在台灣，有近二分之一的頂尖急診是由新光急診的校友打造
許多重大公衛醫療事件，新光急診也扮演了關鍵的角色

而下一個時代的台灣急診醫療，也將要從這裡開始。



未來的台灣急診，會是重要的病患通路

急診對台灣民眾來說早就不是單純的急重症救治、更像是緊急的醫療健康諮詢接口。

新光急診這個接口的功能愈強、分布愈廣，就愈能吸引民眾透過這個入口進到新光醫療體系。穩定且多樣的病患來源，才能夠維持醫療品質、收入與訓練的永續性，新光醫院會更有本錢去應對未來更險峻的醫療生態變化。

好的環境、好的品質、隨時可近

新光急診未來三大發展規畫

加強門內病患的輕重分流

提升醫療品質、減低臨床現場紊亂程度進而提升醫療服務滿意度
同時也避免醫護認知疲倦、提升照護安全

發展最新急症技術

提升醫療品質、改善病患預後並提升醫療服務滿意度
同時也持續維持新光急診專科訓練計畫的吸引力與豐富度

增加急診觸角

增加民眾選擇進入新光醫療體系的機會，進而提升醫院營運
同時也能增加醫院主治醫師容額，讓完善訓練的住院醫師得以留下

新光急診未來三大發展規畫

加強門內病患的輕重分流

提升醫療品質、減低臨床現場紊亂程度進而提升醫療服務滿意度
同時也避免醫護認知疲倦、提升照護安全



急診加護病房

發展最新急症技術

提升醫療品質、改善病患預後並提升醫療服務滿意度
同時也持續維持新光急診專科訓練計畫的吸引力與豐富度



先進與革新急症技術中心

增加急診觸角

增加民眾選擇進入新光醫療體系的機會，進而提升醫院營運
同時也能增加醫院主治醫師容額，讓完善訓練的住院醫師得以留下



社區急診基地

急診加護病房

12 + 2 床急診加護病房

其中 12 床為標準加護病房配置，可收治各式內外科病患
2 床為彈性病床，用以日常運行緊急侵入性檢查治療、並當作彈性收治病患使用

發展重症早期偵測與預先處置

基於急診過往案例庫建立「SKHEW 新光醫院早期預警系統」
讓部分病患是在惡化前就已被收入加護病房

建立院內重症病床的緩衝區

在連續假日、夜間，或臨床權責尚不明的時候，可讓危急病患更快進到受控的加護病房環境、提供更好醫療品質

急診加護病房

減低急診現場紊亂程度

讓急診可以更快將輕重症病患分開

減少急診看起來像是戰場的時間，進而提升輕症服務品質與輕症病患吸引力

避免醫護認知疲倦

獨立環境讓醫護全力處理當班所遇到的急重難罕

增加每位病患被醫師與護理師評估的時間與精確程度

急診加護病房

困難的、複雜的、場面浩大的，我們關起門來弄
醫護處理起來會更得心應手
病患照護品質會更好
急診現場環境也會更好、更能吸引輕中症民眾就醫

先進與革新急症技術中心

發展超音波介入治療

利用急診加護病房的彈性區域，建立可由超音波執行的各科別侵入性處置環境
處置後須觀察的病患可就地收治、也可以把檢查室、電腦斷層、開刀房留給更多需要的病患

急性疼痛神經阻斷

可提供疼痛應變小組，為外傷、部分術後，提供超音波導引神經阻斷
另也計畫發展神經阻斷輔助的術後加速復原計畫、讓骨科病患能盡快下床活動

急性處置情境的 PSA

急診醫學會的鎮靜處置委員會與本院急診密切相關
已計畫承接學會任務、全力發展屬於台灣急性醫療所需要使用的輕中度鎮靜流程

先進與革新急症技術中心

整併目前科上既有中心，改以「單一中心、不同階段任務」的設計進行

目前急診非常多臨床實務中心，這些中心在成立當初所代表的都是當時最進步的急診技術
未來將由本中心統籌所有新技術發展的事務，減少臨床醫師想發展新技術時所需額外投入的行政負擔

以3-5年為架構
規劃發展重點

利用急診與
急診加護病房
進行實作

產出可轉譯到
台灣其他急診
的臨床流程

目前第一期計畫本中心以「影像導引臨床介入」與「符合台灣使用的輕中度鎮靜流程」為目標，而這兩者預計會是在3~5年內台灣急診醫學重點發展的領域，目前也都是由新光校友領銜發展！

先進與革新急症技術中心

我們將實踐創辦人「維持現狀，即是落伍」的創新精神
傾力打造這個中心成為
急診技術的輸出源頭、急重症人才的搖籃、民眾與醫療同儕信賴的團隊

區域急診基地

新光急診為中心獨立於政府規劃外的急診網絡

在新醫療資訊輔助系統的幫助下，建立屬於新光醫療體系自己的快速轉診網路（SKHTN）

由急診醫學科備受信賴的主治醫師群，將附近的小型醫院急診室、未來開設的 UCC 納入旗下成新光醫院的社區接口



區域急診基地

智慧檢傷急診入口

透過智慧檢傷評估民眾不舒服時的風險程度，將病患引導入新光醫療體系駐點的快速通道就診

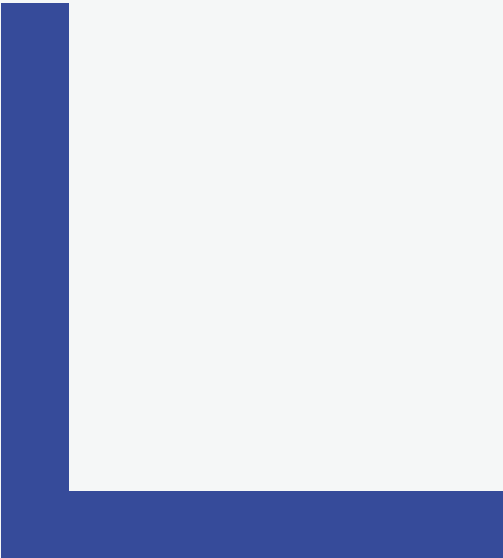
EMS 緊急救護訓練中心

承接既有 EMS 中心之業務，完善新光醫療體系與政府 EMS 的溝通與協調
並持續提通如以往高品質的相關訓練

區域急診基地

鎖定區域廣布接口
讓民眾只要是就醫，就接入新光醫療體系

而透過急診進駐與報備支援的方式整合社區小型醫療體系
不僅高效、立即可行
以合作的樣貌進行也會有較好的團隊形象、較彈性的應變能力



我們的團隊

All from SKHER



醫師

醫師

李瑋恩醫師

台灣急診醫學會急診專科醫師

台灣急診醫學會鎮靜止痛工作小組委員

新光醫院急診醫學科主治醫師

雙和醫院先進與革新急症技術中心創辦團隊暨執行秘書

—

急診醫學的未來，總是從新光開始

Reinvent the Landscape of Emergency Medicine

